



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : ام هاشم عبد الله حفني عوض

العنوان : البدرشين

المحافظة : القاهرة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 29-09-2026

رقم البطاقة : 28006052101127 رقم التليفون : 01099116946

العمر (تاريخ الميلاد) : 05-06-1980 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي : (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه : (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي زولاديكس تحت الجلد لمدة 6 شهور

قسم العلاج :
الأورام

[14163]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني : الوظيفة : : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن : الوظيفة : : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان : الوظيفة : : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / / د. / / د. / / د. /

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : : قسم :
جهة العلاج : : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: ام هاشم عبد الله حفني عوض National ID: 28006052101127	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Goserelin (Zoladex) subcutaneous

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



دولة الكويت
الجمهورية العربية الإسلامية
الكويتية

م حشم
عبدالله حشم عوض
تربية ستار
مركز التميز والتميز

٢٨٠٠٥٠٥٢١٠١١٣٧

KP7536103

٢٨٠٠٥٠٥٢١٠١١٣٧



٢٨٠٠٥٠٥٢١٠١١٣٧



م حشم
عبدالله حشم عوض
تربية ستار
مركز التميز والتميز



Patient Name : الأم هالة / أم هالة عبدالله حنفى	Request No. : 13003068
Patient Mo. : 28006052101127	Request Date : 09/03/2024
Path No. : 969/24	Verification Date : 24/03/2024
Sex : Female	Financial Category : دم - نفقة الدولة
Age : 43 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa moh

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, Post NACT.

Source of the specimen: Left MRM, collected at 7/3/2024.

Gross Examination:

Procedure: Left MRM specimen measured 26x16x5 cm, covering skin ellipse measured 15x15 cm, nipple and areola were unremarkable grossly.

Tumor extent

Number: Two ill defined grayish white TBS. 1.5 cm from each other.

Size: 3x1.5x1.5 cm and 3x2x1 cm.

Lymph node involvement: No

Distance from margins: 2 cm from deep margin

Lymph nodes number and size: 8 nodules up to 3 cm.

Additional pathologic findings: N/A

Immunohistochemistry technique: N/A

Frozen section: N/A

Microscopic examination:

Histological type: No remnants of tumor tissue

Grade (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): N/A

Angiolymphatic invasion: Negative

Ductal carcinoma in situ: No

Lymph node involvement: Free axillary lymph nodes (0/8).

Resection Margins: Free

Histologic response to therapy: PCR

Additional pathologic findings: Free nipple.

Diagnosis:

Verified by :

walaa ghoniem

Print Date : 27/03/2024 10:02:58

Page 1 of 2

Printing By : marwa moh

CAP
ACCREDITED

شرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Mistr El Qadema - Cairo, Egypt

Name: ام هاشم عبدالله حفني		GUSTAVE ROUSSY	
MR. : 4629			
Detailed Medical Report			
		السيد	
تحتية طبية وبعد,,			
		إيماء للطلب المقدم من	
بشأن تقرير طبي للمريض			
رقم طبي:		بقسم:	
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته			
تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه			
The patient was initiated on tamoxifen 20 mg daily, calcium supplementation (1 tablet daily for 90 days), and a single dose of zoladex 10.8 mg administered subcutaneously. Tamoxifen therapy was continued with supportive care for an additional three-month course, as documented for BSM in August 2026. The patient's pathology demonstrated invasive ductal carcinoma, estrogen receptor score 0/8, progesterone receptor score 8/8, HER2 score 3+, clinical stage T3 N2, with >4 cm tumor size, treated with neoadjuvant therapy (TXT + HP) followed by left total mastectomy (MRM) showing no residual tumor tissue. Multidisciplinary discussion in April 2024 concluded that the patient had completed 17 cycles of Phesgo, received postoperative radiotherapy, and was planned for five years of tamoxifen (nolvadex) followed by five years of an aromatase inhibitor. The patient started hormonal therapy in May 2024. The patient has completed 17 cycles of Phesgo.			
تحريراً في ,			
		التاريخ : 19-09-2026	
الوقت :		الطبيب المعالج : يمنى امجد خالد	
يعتمد ,			

Patient Name : الأستاذة / أم هانم عبدالله جفلى
Patient No. : 28006052101127
Request No. : 13003068
Request Date : 09/03/2024
Verification Date : 24/03/2024
Financial Category : نفقة الدولة - رام دار السلام
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed you
Age : 43 Y
Sex : Female
Referring Doc :

Pathology Report

For breast cancer, post NACT; Left MRM:
No residual tumor tissue
Free nipple
Free deep margin
Free axillary lymph nodes (0/8)
pT0 ypN0.

Dr. Rana Fathy
Dr. Walaa Ghoniem

Verified by :
walaa ghoniem

Print Date : 27/03/2024 10:02:58

Page 2 of 2

Printing By : marwa mohamed yous

Request No. : 13003232
Request Date : 10/05/2023
Verification Date : 21/05/2023
Financial Category : أورام دار السلام - فئة الدولة
Department : Out Patient
IHC No. :
Registered by : marwa mohamed yousse

al Data: Left breast mass.

Examination:

Topic Examination:

carcinoma in situ: No.

carcinoma in situ: No.

Ural invasion: No.

Invasion: No.

nal pathologic findings:
positive

positive control showed appropriate reactivity):
long nuclear reaction in 30%.

ong nuclear reaction in 70% of tumor cells (Allred score 8/8).

long nuclear reaction in 80 % of tumor cells (Allred score 8/8).

Long complete membrane reaction in >10 % of tumor cells (score 3+).

% nuclear reaction of tumor cells.

t mass, Tru-cut biopsy:
duct carcinoma, GII.

Verified by:

DR. Menna Nabil

Date: 21/03/2023 10:31:59

Page 1 of 2

Printed By : marwa mohamed youss

Request No.	13003232
Request Date	10/05/2023
Verification Date	21/05/2023
Financial Category	ار. السلام - نفقة الدولة
Department	Out Patient

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Positive (score 3+).
- Ki67: Positive in 18% of tumor cells.

Signature
Prof. Dr. Lobna Omar.
Dr. Heba Mustafa

Printing Date : 21/05/2023 10:31:59

Page 2 of 2

Printed By : marwa mohamed y

Patient ID:

1- Name: ام هاشم شريانه حنفي عوض

Sex:

MDT form

3- Medical number:
Female

83144545

Old Med:

QCR Med

1983-2023

2-ID number: 28005052101127

Patient Age: 44 Y

Family history	Family history -ve	Phone	Phone 01063842427	BMI	BMI	REASON OF MDT	REASON OF MDT
Marital status	Marital status	NRS Score	NRS Score	GROUP	GROUP	Date of MDT	Date of MDT 16/04
Co morbidity	Co morbidity -ve	Menopausal status	Menopausal status -ve	Initial STAGE	Initial STAGE		

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

BX IOC BX - SNEHET	ER 8/8 ER COMMENT	PR 8/8 PR COMMENT	Her 2 Neu 3 Her 2 Neu COMMENT	SISH SISH COMMENT	Ki67 18
--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	----------------------	------------

T 3	N 2	M 0
--------	--------	--------

Sonomammography

LT UOQ MULTIFOCAL MASSES,,AT 2O'CLOCK 4.6X2.8CM,,AT 3 O'CLOCK 2.2X2.4CM
MULTIPLE STALITTE 7X6.4MM,,ONE AXILLARY PLNS,,ONE INFRACLAV 9X5MM

PATIENT HISTORY

LAST MDT 23/8/2023-->DUE TO QUERY SLUGGISH RESPONSE FOR NEW BSM
IF RESPONSE CONTINUE THE 4TH CYCLES AC THEN ANOTHER

4 CYCLES TAXOTYERE/HERCEPTIN PERJETA

IF NOT RESPONDING TO SHIFT DIRECTLY TO TAXOTYERE/CARBOPLATIN/
HERCEPTIN/PERJETA 4-6 CYCLES

BSM shows progression so shifted to taxotere / carbo x 7 cycles+ phesgo x 4 cycles with go
clinical response

LT MRM:no residual tumor tissue+free nipple , deep margins

free axillary LN C/8

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

Complete 17 cycle phesgo ,, PORT,,, 5 YEARS nolvadex then 5 AI

MEDICAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY	RADIOLOGY	RADIOLOGY
SURGERY	SURGERY	PATHOLOGY	PATHOLOGY
Psychiatric	Psychiatric	Nutrition	Nutrition

NAME: Om Hashem Abd Allah

DATE : 4-08-2023

Referred by Prof. Dr.: «Professor»

MULTISLICE POST CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN AND PELVIS:

FINDINGS:

(I) Chest:

- Patent central air ways with well inflated both lungs.
- Both lung fields are clear showing no parenchymal nodules, cavitory lesions, consolidative patches or bronchiectatic changes.
- No CT evidence of hilar or mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collections seen.
- No gross cardiac abnormality.

(II) Abdomen and pelvis:

- The liver is average in size showing homogenous CT density with no focal lesions.
- Patent and homogeneously enhancing portal vein.
- No intra or extra hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, both kidneys, aorta and IVC.
- Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses or diverticulae.
- RT ovary show oval shape cyst about 40x30mm showing thin wall and low density content
- Normal appearance of uterus ad LT ovary
- Unremarkable other pelvic organs.
- No retro-crural, para-aortic or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.

OPINION:

- Normal post contrast CT chest study.
- Normal post contrast CT abdomen study
- RT ovarian small benign looking cyst for follow up

*Kindly Accept My Best Wishes,
Dr. Ahmed Daraka, FRCR*

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



ام هاشم
عبدالله حنفى عوض
قرية سقاره
مركز البدرشين - الجيزة

١٩٨٠/١٠/١٥

٢٨٠٠٦٠٥٢١٠١١٢٧

KP1536103

٢٠٢٤/٠٦ ٢٨٠٠٦٠٥٢١٠١١٢٧

ربة منزل

أنثى مسلمة متزوجة

رضا محمد ابراهيم ابوشاهين

البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/٠٦/١٢





Patient's Name:

Umm Hashim Abdullah Hifni Awad

Date:

2026-08-04

Referred by:

Prof.Dr. no doctor

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt

Right Digital soft tissue mammography with high resolution sonography revealed:

Clinical summary: Status post left MRM routine follow up.

Findings:

Right breast

- Scattered fibro-glandular densities. (ACR b)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left mastectomy bed

- Clear mastectomy bed with no masses or fluid collections.
- Clear right axilla. No pathological supra or infra-clavicular lymph nodes.
-

Conclusion:-

- *Right breast (BIRADS 1): normal study.*
- *Clear left mastectomy bed and axilla.*

Recommendation:-

- *For annual follow up.*

Best Regards,

DR. Marwa M.Hassan



Patient Name: Om Hashem Abd Allah Hanafy Awad	Date : 24/01/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 43 Year(s)
Medical ID: 1983/2023	Pat. ID: 43676

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION
ULTRASOUND**

Indication:

Known case of left breast cancer on therapy

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral 3D MLO DBT (Digital Breast tomosynthesis)
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Still noted architectural distortion with underlying suspicious pleomorphic microcalcifications.>>> all over area about 11x43mm.

Complementary ultrasound :

- Left UOQ small area of subtle parenchymal distortion measuring about 27x8mm.
- No right cystic or solid mass lesions.
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
- Bilateral Nonspecific axillary LN.
- Free supra and infra clavicular lymph nodes.

Opinion:

- Left breast UOQ pathologically proven carcinoma showing partial radiological response with underlying suspicious microcalcifications. (BIRADS 6)
- Right breast benign finding (BIRADS2)

Signature Dr. Nehal Hamdy

24/01/2024 2:01 PM



Patient Name: Om Hashem Abd Allah Hanafy Awad	Date : 24/01/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 43 Year(s)
Medical ID: 1983/2023	Pat. ID: 43676

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION
ULTRASOUND**

Indication:

Known case of left breast cancer on therapy

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral 3D MLO DBT (Digital Breast tomosynthesis)
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Still noted architectural distortion with underlying suspicious pleomorphic microcalcifications.>>> all over area about 116x43mm.

Complementary ultrasound :

- Left UOQ small area of subtle parenchymal distortion measuring about 27x8mm.
 - No right cystic or solid mass lesions.
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
- Bilateral Nonspecific axillary LN.
- Free supra and infra clavicular lymph nodes.

Opinion:

- Left breast UOQ pathologically proven carcinoma showing partial radiological response with underlying suspicious microcalcifications. (BIRADS 6)
- Right breast benign finding (BIRADS2)

Signature Dr. Nehal Hamdy

24/01/2024 2:01 PM

Patient's Name: Umm Hashim Abdullah Hifni Awad
Date: 2026-08-04
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt



Right Digital soft tissue mammography with high resolution sonography revealed:

Clinical summary: Status post left MRM routine follow up.

Findings:

Right breast.

- Scattered fibro-glandular densities. (ACR b)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left mastectomy bed.

- Clear mastectomy bed with no masses or fluid collections.
- Clear right axilla. No pathological supra or infra-clavicular lymph nodes.

Conclusion:-

- *Right breast (BIRADS 1): normal study.*
- *Clear left mastectomy bed and axilla.*

Recommendation:-

- *For annual follow up.*

Best Regards,

DR. Marwa M.Hassan



ERM036726187

~~122~~

157

5218

مستند
پر
۲۱/۱۰/۲۱





Patient Name: Om Hashem Abd Allah Hanafy Awad	Date : 05/05/2025
Exam : ultrasound ABDOMEN& PELVIS	Age : 45 Year(s)
Medical ID: 1983/2023	Pat. ID: 43676

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- *enlarged in size (17cm at Rt MCL) homogenous parenchymal echopattern with smooth surface.*
- *No hepatic focal lesions or intra hepatic billiary radicle dilatation.*
- *Portal vein is patent and not dilated.*

Gall Bladder: -

- *Average distention and capacity with no stones or mud*
- *The wall is not thickened.*
- *CBD is not dilated.*

Spleen: -

- *Average size, homogenous.*

Kidneys: -

- *Duplex right kidney with suspected lower malrotated the left kidney is ectopic*
- *Both are average in size, shape and echogenicity*
- *No stones or dilated pelvicalyceal system*
- *No gross lesion*

Para-aortic and pancreatic area: *show no gross abnormalities.*

No ascites

Urinary Bladder: -

- *Average capacity with no stones or diverticular out pouching*

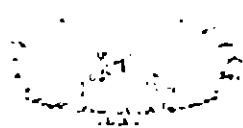
Uterus and adnexal; *no abnormalities could be detected*

Opinion:

Hepatomegaly
Duplex right kidney
Ectopic left kidney
Colonic gaseous distention

Signature Dr . Nermien Ramadan

05/05/2025 2:14 PM



Ministry of Health and Population
Kingdom of Saudi Arabia

الوزارة العامة للصحة والسكان
الجمهورية العربية السعودية



MDT form

A-Patient ID:

1- Name: أم هاشم عبدك جنتي نوح

Sex:

3- Medical numbers:

Female

83144545

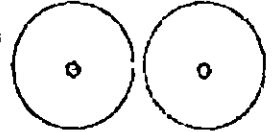
Old Med:

Date of MDT

1983-2023

2-ID number: 28006052101127

Patient Age: 44 Y



Family history

Family history
-VE

Phone:

Name

01063842427

DHI

DHI

REASON OF MDT

REASON OF MDT
FIRST CONSULTATION

Marital status:

Marital status

NRS Score

NRS Score

GROUP

GROUP

Date of MDT

Date of MDT

16/04/2024

Comorbidity

Comorbidity
-VEMenopausal
statusMenopausal status
Early menopause

Initial STAGE

Initial STAGE

Clinical data

Breast Imaging:

Mets Workup:

BX IDC	ER 8/B	PR 8/B	Her 2 Neu 3	SISH	K167 15
ER COMMENT	ER COMMENT	PR COMMENT	Her 2 Neu COMMENT	SISH COMMENT	

T 3	N 2	M 0
--------	--------	--------

Sonomammography

LT UOQ MULTIFOCAL MASSES,,AT 20'CLOCK 4.6X2.8CM,,AT 3 O'CLOCK 2.2X2.4CM
MULTIPLE STALITTE 7X6.4MM,,ONE AXILLARY PLNS,,ONE INFRACLAV 9X5MM

PATIENT HISTORY

LAST MDT 23/8/2023-->DUE TO QUERY SLUGGISH RESPONSE FOR NEW BSM

IF RESPONSE CONTINUE THE 4TH CYCLES AC THEN ANOTHER

4 CYCLES TAXOTYERE/HERCEPTIN PERJETA

IF NOT RESPONDING TO SHIFT DIRECTLY TO TAXOTERE/CARBOPLATIN/

HERCEPTIN/PERJETA 4-6 CYCLES

BSM shows progression so shifted to taxotere / carbo x 7 cycles+ phesgo x 4 cycles with good clinical response

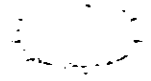
LT MRM:no residual tumor tissue+free nipple , deep margins

free axillary LN 0/8

MDT OUTCOME & PLAN

Complete 17 cycle phesgo ,, PORT,,, 5 YEARS nolvadex then 5 AI + Zoladex.

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY		RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	



Patient Name	الأستاذة / ام هاشم عبدالله حنفى	Request No.	13003232
Patient No.	28006052101127	Request Date	10/05/2023
Path No.	1372/2023	Verification Date	21/05/2023
Sex	Female	Financial Category	اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	42 Y	Department	Out Patient
Referring Doc.		Registered by	.marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

- ER: Positive (score8 /8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Positive (score 3+).
- Ki67: Positive in 18% of tumor cells.

Signature
Prof. Dr.Lobna Omar.
Dr. Heba Mustafa.

Verified by :





Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name : أم هشام عبدالله حنظل عوض

Sex:

3- Medical number:

Female

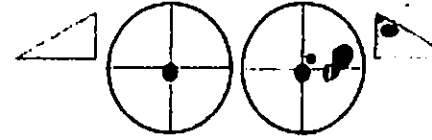
83144545

Old Med :

1983/2023

2-ID number: 28006052101127

Patient Age : 43 Y



Family history

Phone

010999116946

BMI

REASON OF MDT

NEW

marital status

NRS Score

GROUP

Date of MDT

2023-06-14

Co morbidity

Menopausal status

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

CT RT OVARIAN SMALL BENIGN LOOKING CYST

BX:

IDC

ER:

8/8

PR:

8/8

Her 2 Neu :

3

SISH :

KI67 :

18

GII,,LT

T

N

M

Sonomammography

LT UOQ MULTIFOCAL MASSES,,AT 20'CLOCK 4.6X2.8CM,,AT 3 O'CLOCK 2.2X2.4CM
MULTIPLE STALITTE 7X6.4MM,,ONE AXILLARY PLNS,,ONE INFRACLAV 9X5MM

PATIENT HISTORY

MDT OUTCOME & PLAN

start zoladex +NACT (ACx4 then Taxotere x4) guided by clinical response then consider LT MRM.

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	د. هادي لامين	RADIOLOGY	د. هادي لامين
SURGERY	د. هادي لامين	PATHOLOGY	د. هادي لامين
Psychiatric		Nutrition	

Echo report

Name: محمد علي

Date: 15/11/2024

MR: 1982
CX

EF	70%	55-75%	PWT	0.8	0.6-1.1cm
LVEDD	5	3.5-5.8cm	AO.R	2.2	2-3.7cm
LVESD		2-4cm	LA	3.5	2-4cm
FS		25-45%	RV		0.7-2.3cm (supine)
SWT	0.7	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV Dimensions normal

LV wall thickness normal

LV diastolic function normal

SWMA normal

LA and Aortic root dimensions normal

Mitral Valve normal morphology T1k TR

Aortic valve normal

Tricuspid valve T1k TR

Pulmonary valve normal

Right side and systolic function normal

Intracardiac masses and effusion normal

D/Msc cardiology

د/مبا علي

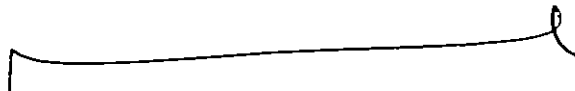
1982
٢٢

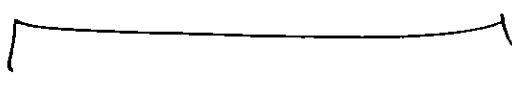
وزارة الصحة والسكان
امانة المستشفى الطبية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام

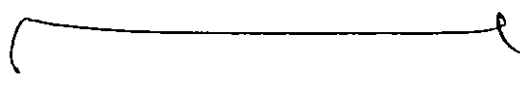
Dr. / أحمد عبد الله حفيظ **Echo report**

Na
D: 15/1/2023

EF	65%	55-75%	PWT		0.6-1.1cm
VEDD	4.6	3.5-5.8cm	AO.R	3.0	2-3.7cm
VESD	2.9	2-4cm	LA	3.0	2-4cm
FS	35%	25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
PWT	0.9	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

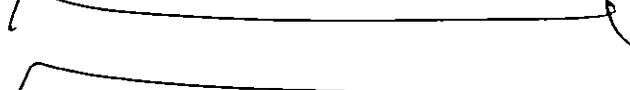
LV dimensions 

LV wall thickness 

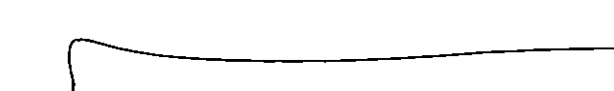
LV systolic function 

SV  No pericardial effusion at rest

LA Aortic root dimensions 

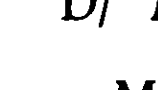
Mitral Valve 

Aortic valve 

Tricuspid valve 

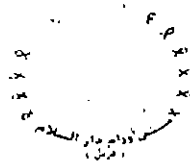
Primary valve 

Right side and systolic function 

Intracardiac masses and effusion 

D/ Mohamed Ali

Msc cardiology



Patient Name: Om Hashem Abd Allah Hanafy Awad	Date : 24/01/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 43 Year(s)
Medical ID: 1983/2023	Pat. ID: 43676

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION
ULTRASOUND**

Indication:

Known case of left breast cancer on therapy

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral 3D MLO DBT (Digital Breast tomosynthesis)
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Still noted architectural distortion with underlying suspicious pleomorphic microcalcifications.>>>> all over area about 116x43mm.

Complementary ultrasound :

- Left UOQ small area of subtle parenchymal distortion measuring about 27x8mm.
- No right cystic or solid mass lesions.
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
- Bilateral Nonspecific axillary LN.
- Free supra and infra clavicular lymph nodes.

Opinion:

- Left breast UOQ pathologically proven carcinoma showing partial radiological response with underlying suspicious microcalcifications. (BIRADS 6)
- Right breast benign finding (BIRADS2)

Signature Dr. Nehal Hamdy

24/01/2024 2:01 PM



عبد الله محمد
19/2 Echo report

Name:

Date: 7/10/2023

MR: 19/12/25

EF	64%	55-75%	PWT	9.96	
LVEDD	4.58	3.5-5.8cm	AO.R	2.12	2-3.7cm
LVESD	2.99	2-4cm	LA	3.13	2-4cm
FS	34%	25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT	0.96	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV dimensions

Normal

LV wall thickness

Normal

LV diastolic function

Normal

SWMA

No SWMA

LA and Aortic root dimensions

Normal

Mitral Valve

Normal

Aortic valve

Normal

Tricuspid valve

Normal

Pulmonary valve

Normal

Right side and systolic function

Not Dilated, Normal function

Intracardiac masses and effusion

No effusion, no masses

D/ Msc cardiology

Dr. Khaled



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name : اد هاشم عبدالله حنفي عوض

Sex:

3- Medical number:

Female

83144545

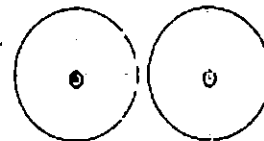
Old Med :

Old Med :

1983-2023

2-ID number: 28006052101127

Patient Age: 44 Y



Family history

Family history
-ve

Phone

Phone

01063842427

BMI

BMI

REASON OF MDT

REASON OF MDT
POST OPERATIVE

marital status

Marital Status

NRS Score

NRS Score

GROUP

GROUP

Date of MDT

Date of MDT

16/04/2024

Co morbidity

Co morbidity
-veMenopausal
statusMenopausal Status
PRE MENOPAUSA

Initial STAGE

Initial STAGE

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

BX IDC	ER 8/8	PR 8/8	Her 2 Neu 3	SISH K167 18
BX COMMENT:	ER COMMENT	PR COMMENT	Her 2 Neu COMMENT:	SISH COMMENT :

T 3	N 2	M 0
--------	--------	--------

Sonomammography

LT UOQ MULTIFOCAL MASSES,,AT 20'CLOCK 4.6X2.8CM,,AT 3 O'CLOCK 2.2X2.4CM
MULTIPLE STALITTE 7X6.4MM,,ONE AXILLARY PLNS,,ONE INFRACLAV 9X5MM

PATIENT HISTORY

LAST MDT 23/8/2023-->DUE TO QUERY SLUGGISH RESPONSE FOR NEW BSM
IF RESPONSE CONTINUE THE 4TH CYCLES AC THEN ANOTHER
4 CYCLES TAXOTYERE/HERCEPTIN PERJETA

IF NOT RESPONDING TO SHIFT DIRECTLY TO TAXOTERE/CARBOPLATIN/
HERCEPTIN/PERJETA 4-6 CYCLES

BSM shows progression so shifted to taxotere / carbo x 7 cycles+ phesgo x 4 cycles with good
clinical response

LT MRM:no residual tumor tissue+free nipple , deep margins
free axillary LN 0/8

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

Complete 17 cycle phesgo ,, PORT,,, 5 YEARS nolvadex then 5 AI

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY د. هاشم عبدالله حنفي عوض	RADIOLOGY	RADIOLOGY د. منير محمد العبدالله
SURGERY	SURGERY د. هاشم عبدالله حنفي عوض	PATHOLOGY	PATHOLOGY
Psychiatric	Psychiatric	Nutrition	Nutrition



Patient Name : الأستاذ / أم هاشم عبدالله حنفى	Request No. : 13003068
Patient No. : 28006052101127	Request Date : 09/03/2024
Path No. : 969/24	Verification Date : 24/03/2024
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 43 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, Post NACT.

Nature of the specimen: Left MRM, collected at 7/3/2024.

Gross Examination:

- Procedure: Left MRM specimen measured 26x16x5 cm, covering skin ellipse measured 19x13 cm, nipple and areola were unremarkable grossly.
- Tumor extent
- Number: Two ill defined grayish white TBS. 1.5 cm from each other.
- Size: 3x1.5x1.5 cm and 3x2x1 cm.
- Skin involvement: No
- Distance from margins: 2 cm from deep margin
- Lymph nodes number and size: 8 nodules up to 3 cm.
- Additional pathologic findings: N/A
- Immunohistochemistry technique: N/A
- Frozen section: N/A

Microscopic examination:

- Histological type: No remnants of tumor tissue
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): N/A
- Angioinvasion: Negative
- Ductal carcinoma in situ: No
- Lymph node involvement: Free axillary lymph nodes (0/8).
- Resection Margins: Free
- Histologic response to therapy: PCR
- Additional pathologic findings: Free nipple.

Diagnosis:

Verified by :
walaa ghoniem

Printing Date : 27/03/2024 10:02:58

Page 1 of 2

Printing By : .marwa mohamed youss

CAP
ACCREDITED

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt



Patient Name : الأستاذة / أم هاشم عبدالله حفي	Request No. : 13003068
Patient No. : 28006C52101127	Request Date : 09/03/2024
Cash No. : 969/24	Verification Date : 24/03/2024
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 43 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

Left breast cancer, post NACT; Left MRM:
- No residual tumor tissue
- Free nipple
- Free deep margin
- Free axillary lymph nodes (0/8)
- ypT0 ypN0.

Dr. Rana Fathy
Dr. Walaa Ghoniem

Verified by :
walaa ghoniem

Printing Date : 27/03/2024 10:02:58

Page 2 of 2

Printing By : .ma wa mohamed youss



Patient Name : الأستاذة / أم هاشم عبدالله حنفى :

Request No. : 13003232

Patient No. : 28006052101127

Request Date : 10/05/2023

Path No. : 1372/2023

Verification Date : 21/05/2023

Sex : Female

Financial Category : اورام دار السلام - نفقة الدولة

Age : 42 Y

Department : Out Patient

Referreing Doc. :

IHC No. :

Registered by : .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Left breast mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 9/5/2023, 3:14 pm.

Gross Examination:

- 3 grayish white tissue cores up to 1.5 cm, totally submitted.
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, Her2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma.
- * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) GII.
- * Ductal carcinoma in situ: No.
- * Perineural invasion: No.
- * Angioinvasion: No.
- * Additional pathologic findings:
- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
 - ER: strong nuclear reaction in 70% of tumor cells (Allred score 8/8).
 - PR: strong nuclear reaction in 80 % of tumor cells (Allred score 8/8).
 - Her2: strong complete membrane reaction in >10 % of tumor cells (score 3+).
 - Ki67: 18 % nuclear reaction of tumor cells.

Diagnosis:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:

- Invasive duct carcinoma, GII.

IPT:

Verified by :

DR.Menna Nabil

Printing Date : 31/05/2023 10:31:59

Page 1 of 2

Printed By : .marwa mohamed youss

NAME: Om Hashem Abd Allah	DATE : 4-06-2023
Referred by Prof. Dr.: «Professor»	

**MULTISLICE POST CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN AND PELVIS:**

FINDINGS:

(I) Chest:

- Patent central air ways with well inflated both lungs.
- Both lung fields are clear showing no parenchymal nodules, cavitary lesions, consolidative patches or bronchiectatic changes.
- No CT evidence of hilar or mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collections seen.
- No gross cardiac abnormality.

(II) Abdomen and pelvis:

- The liver is average in size showing homogenous CT density with no focal lesions.
- Patent and homogeneously enhancing portal vein.
- No intra or extra hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, both kidneys, aorta and IVC.
- Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses or diverticulae.
- RT ovary show oval shape cyst about 40x30mm showing thin wall and low density content
- Normal appearance of uterus ad LT ovary
- Unremarkable other pelvic organs.
- No retro-crural, para-aortic or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.

OPINION:

- Normal post contrast CT chest study.
- Normal post contrast CT abdomen study
- RT ovarian small benign looking cyst for follow up

*Kindly Accept My Best Wishes,
Dr. Ahmed Daraka, FEBR*



Patient Name	: الأستاذ / ام هاشم عبدالله حنفى	Request No.	: 13003232
Patient No.	: 28006052101127	Request Date	: 10/05/2023
Path No.	: 1372/2023	Verification Date	: 21/05/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 42 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc. :		IHC No.	:
		Registered by	: marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Left breast mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 9/5/2023, 3:14 pm.

Gross Examination:

- 3 grayish white tissue cores up to 1.5 cm, totally submitted.
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, Her2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma.
- * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) GII.
- * Ductal carcinoma in situ: No.
- * Perineural invasion: No.
- * Angioinvasion: No.
- * Additional pathologic findings.
- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
 - ER: strong nuclear reaction in 70% of tumor cells (Allred score 8/8).
 - PR: strong nuclear reaction in 80 % of tumor cells (Allred score 8/8).
 - Her2: strong complete membrane reaction in >10 % of tumor cells (score 3+).
 - Ki67: 18 % nuclear reaction of tumor cells.

Diagnosis:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:
- Invasive duct carcinoma, GII .
IPT:

Verified by :



NAME: Om Hashem Abd Allan	DATE : 4-06-2023
Referred by Prof. Dr. AlProfessors	

MULTISLICE POST CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS:

FINDINGS:

(I) Chest:

- Patent central air ways with well inflated both lungs.
- Both lung fields are clear showing no parenchymal nodules, cavitary lesions, consolidative patches or bronchiectatic changes.
- No CT evidence of hilar or mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collections seen.
- No gross cardiac abnormality.

(II) Abdomen and pelvis:

- The liver is average in size showing homogenous CT density with no focal lesions.
- Patent and homogeneously enhancing portal vein.
- No intra or extra hepatic biliary ducts dilatation.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, both kidneys, aorta and IVC.
- Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses or diverticulae.
- RT ovary show oval shape cyst about 40x30mm showing thin wall and low density content
- Normal appearance of uterus and LT ovary
- Unremarkable other pelvic organs.
- No retro-crural, para-aortic or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.

OPINION:

- Normal post contrast CT chest study.
- Normal post contrast CT abdomen study
- RT ovarian small benign looking cyst for follow up.

*Kindly Accept My Best Wishes,
Dr. Ahmed Daraka, FEBR*

Patient Name: *Om Hoshem Abdul Allah Hefny*
Prof. Dr: *Center harmful*
Accession: *23082406*

Patient ID: *607255*
Exam Date: *24/8/2023*

^{99m}Tc-MDP whole body bone scan

History:

43-year-old female patient has managed breast cancer for assessment of bone.

Physical examination:

Skeletal surveying:

Technique:

Anterior and posterior Delayed Whole body bone scan performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc-MDP;

Findings:

General appearance:

Degenerative changes are noticed in the dorsal & lumbar vertebrae as well as both knee joints.

There is no hot spot that account for osseous deposits could be detected all over the surveyed skeleton.

Both kidneys are visualized.

CONCLUSION:

The surveyed skeleton is free from definite osseous deposits

Best regards:
Dr. Huda Fathy M.D.



مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

الاستشارة
طبية
مصر

MDT FORM

/ / 20

G

Name	ام هاشم عبدالله فتحي عوض	MRN	1983 / 2023
		ID	13122020
Age	44	Phone	01063842427
Menopausal status	pre	Marital status	1-99971-VE
NRS SCORE		Family history	-ve
BMI		REASON OF MDT	Post surgical (T.M.M.)
CO morbidity	-ve		1-99117927

Clinical Data

BX: IDC	R	L
ER: 8/8	PR: 8/8	HER 2: 3
KI67: 18		
Sonomammography: Lt Uoq multifocal mass at 2'clock 4.6x2.8cm 304cm 2x2.4 Multiple satellite 7x6.4mm		
Mets Workup:		

Recommendations:

Post NACT = Lt MRM No residual tumor tissue + Free nipple +
Free deep margin - Free axillary LN (0/8) To No

MDT OUTCOME & PLAN

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric



Echo report

ام هادي عبد الله حبي

MR : 1983
23

Name:

Date: 15/2/2024

EF	66 %	55-75%	PWT		
LVEDD	4.4	3.5-5.8cm	AO.R	3.3	2-3.7cm
LVESD	2.8	2-4cm	LA	3.5	2-4cm
FS	34 %	25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT	1.1	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV dimensions

LV wall thickness

LV diastolic function

SWMA NO SWMA at rest

LA and Aortic root dimensions

Mitral Valve

Aortic valve

Tricuspid valve

Pulmonary valve

Right side and systolic function

Intracardiac masses and effusion NO

D/Mohamed Ali

Msc cardiology



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

**MDT form**

A-Patient ID:

1- Name : ام هاشم عبدالله حنفي عوض

Sex:

3- Medical number:

Female

83144545

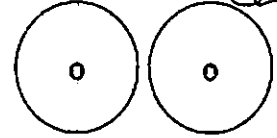
Old Med :

Old Med :

1983-2023

2-ID number: 28006052101127

Patient Age : 44 Y



Family history

Family History

Phone

Phone

01063842427

BMI

BMI

REASON OF MDT

REASON OF MDT
POST NACT

marital status

Marital Status

NRS Score

NRS Score

GROUP

GROUP

Date of MDT

Date Of MDT

07/02/2024 ☐

Co morbidity

Co Morbidity
freeMenopausal
status

Menopausal Status

Initial STAGE

Initial STAGE

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

BX IDC BX COMMENT:	ER 8/8 ER COMMENT:	PR 8/8 PR COMMENT:	Her 2 Neu 3 Her 2 Neu COMMENT:	SISH SISH COMMENT :	Ki67 18
--	--	--	--	-------------------------------	--------------------------

T 3	N 2	M 0
----------------------	----------------------	----------------------

Sonomammography

LT UOQ MULTIFOCAL MASSES,,AT 2O'CLCOK 4.6X2.8CM,,AT 3 O'CLOCK 2.2X2.4CM
MULTIPLE STALITTE 7X6.4MM,,ONE AXILLARY PLNS,,ONE INFRACLAV 9X5MM

PATIENT HISTORY

LAST MDT 23/8/2023-->DUE TO QUERY SLUGGISH RESPONSE FOR NEW BSM
IF RESPONSE CONTINUE THE 4TH CYCLES AC THEN ANOTHER
4 CYCLES TAXOTYERE/HERCEPTIN PERJETA
IF NOT RESPONDING TO SHIFT DIRECTLY TO TAXOTERE/CARBOPLATIN/

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

for LT MRM.

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY د/ نهاده لاشين	RADIOLOGY Reham Amra	RADIOLOGY د/ نهاده الور
SURGERY	SURGERY د/ نهاده الور	PATHOLOGY	PATHOLOGY
Psychiatric	Psychiatric	Nutrition	Nutrition

Patient Name	الأستاذة / ام هانم عبدالله حنفى
Patient No.	2830605213-127
Path No.	1372/2023
Sex	Female
Age	42 Y
Referring Doc.	

Request No.	13003232
Request Date	10/05/2023
Verification Date	21/05/2023
Financial Category	اورام دار السلام - نفقة الوجة
Department	Out Patient
Registered by	marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

- ER: Positive (score 8 /8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Positive (score 3+).
- Ki67: Positive in 18% of tumor cells.

Signature
Prof. Dr. Lobna Omar.
Dr. Heba Mustafa.

Verified by :
DR.Menna Nabil

Printing Date : 31/05/2023 10:31:59

Page 2 of 2

Printed By : .marwa mohamed youss



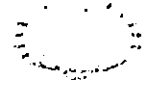
Patient Name	الأستاذة / ام هاشم عبدالله حفتي	Request No.	13003232
Patient No.	28006052101127	Request Date	10/05/2023
Path No.	1372/2023	Verification Date	21/05/2023
Sex	Female	Financial Category	اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	42 Y	Department	Out Patient
Referring Doc.		Registered by	.marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

- ER: Positive (score 8 /8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Positive (score 3+).
- Ki67: Positive in 18% of tumor cells.

Signature
Prof. Dr. Lobna Omar.
Dr. Heba Mustafa.

Verified by :
DR.Menna Nabil



Patient Name	: الأستاذة / ام هاشم عبدالله حنفى	Request No.	: 13003232
Patient No.	: 28006052101127	Request Date	: 10/05/2023
Path No.	: 1372/2023	Verification Date	: 21/05/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة التولية
Age	: 42 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc. :		IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Left breast mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 9/5/2023, 3:14 pm.

Gross Examination:

- 3 grayish white tissue cores up to 1.5 cm, totally submitted.
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, Her2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma.
- * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) GII.
- * Ductal carcinoma in situ: No.
- * Perineural invasion: No.
- * Angioinvasion: No.
- * Additional pathologic findings:
- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
 - ER: strong nuclear reaction in 70% of tumor cells (Allred score 8/8).
 - PR: strong nuclear reaction in 80 % of tumor cells (Allred score 8/8).
 - Her2: strong complete membrane reaction in >10 % of tumor cells (score 3+).
 - Ki67: 18 % nuclear reaction of tumor cells.

Diagnosis:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:

- Invasive duct carcinoma, GII .

IPT:

Verified by :

DR.Menna Nabil



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name : ام هاشم عبدالله حنفي عوض

Sex:

3- Medical number:

Female

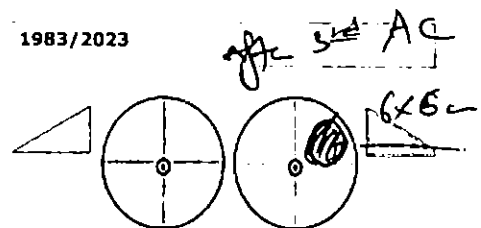
83144545

Old Med :

1983/2023

2-ID number: 28006052101127

Patient Age : 43 Y



Family history

Phone

01099116946

BMI

31

REASON OF MDT

REMDT

marital status

NRS Score

1

GROUP

A

Date of MDT

2023-08-23

Co morbidity

Menopausal
status

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

CT RT OVARIAN SMALL BENIGN LOOKING CYST

BX: IDC LT GII	ER: 8/8	PR: 8/8	Her 2 Neu : 3	SISH :	KI67 : 18
----------------------	------------	------------	------------------	--------	--------------

T 3	N 2	M 0
--------	--------	--------

Sonomammography

LT UOQ MULTIFOCAL MASSES,,AT 20'CLCOK 4.6X2.8CM,,AT 3 O'CLOCK 2.2X2.4CM
MULTIPLE STALITTE 7X6.4MM,,ONE AXILLARY PLNS,,ONE INFRACLAV 9X5MM

PATIENT HISTORY

LAST MDT 14/6/2023--> start zoladex + NACT (ACx4 then Taxotere x4) guided by
clinical response then consider LT MRM.

pt received 3 cycles AC LAST ON 17/08/2023 WITH QUERY SLUGGISH RESPONSE FOR NEW BSM
FOR BONE SCAN

MDT OUTCOME & PLAN

DUE TO QUERY SLUGGISH RESPONSE FOR NEW BSM

IF RESPONSE CONTINUE THE 4TH CYCLES AC THEN ANOTHER 4 CYCLES TAXOTYERE/HERCEPTIN PERJETA
IF NOT RESPONDING TO SHIFT DIRECTLY TO TAXOTERE/CARBOPLATIN/HERCEPTIN/PERJETA 4-6 CYCLES
THEN LT MRM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	د/هشام لاسين	RADIOLOGY	د/هشام لاسين
SURGERY	د/ابراهيم عبدالرحمن	PATHOLOGY	د/ابراهيم عبدالرحمن
Psychiatric		Nutrition	د/ابراهيم عبدالرحمن



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name : ام هشام عبدالله حنفي عوض

Sex:

3- Medical number:

Female

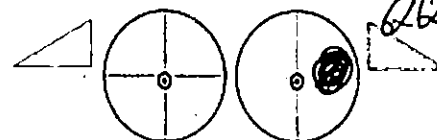
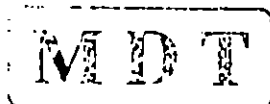
83144545

Old Med :

1983/2023

2-ID number: 28006052101127

Patient Age : 43 Y



Family history

Phone

01099116946

BMI

31

REASON OF MDT

REMDT

marital status

NRS Score

1

GROUP

A

Date of MDT

2023-08-30

Co morbidity

Meno-pausal
status

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

BX: IDC LT GII	ER: 8/8	PR: 8/8	Her 2 Neu : 3	SISH : 	Ki67 : 18
----------------------	------------	------------	------------------	------------	--------------

T 3	N 2	M 0
--------	--------	--------

Sonomammography

LT UOQ MULTIFOCAL MASSES,,AT 20'CLOCK 4.6X2.8CM,,AT 3 O'CLOCK 2.2X2.4CM
MULTIPLE STALITTE 7X6.4MM,,ONE AXILLARY PLNS,,ONE INFRACLAV 9X5MM

PATIENT HISTORY

LAST MDT 23/8/2023-->DUE TO QUERY SLUGGISH RESPONSE FOR NEW BSM
IF RESPONSE CONTINUE THE 4TH CYCLES AC THEN ANOTHER
4 CYCLES TAXOTYERE/HERCEPTIN PERJETA
IF NOT RESPONDING TO SHIFT DIRECTLY TO TAXOTERE/CARBOPLATIN/
HERCEPTIN/PERJETA 4-6 CYCLES
THEN LT MRM

MDT OUTCOME & PLAN

sonomammography show disease progression so shifted to taxotere/carboplatin/herceptin/perjeta

6-8 cycles

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	د/نبينا لاشين	RADIOLOGY	د/نبينا لاشين
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name : ام هاشم عبدالله حنفي عوض

Sex:

3- Medical number:

Female

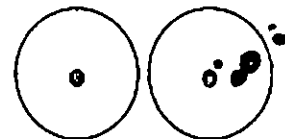
83144545

Old Med :

1983/2023

2-ID number: 28006052101127

Patient Age : 43 Y



Family history

Phone

01099116946

BMI

REASON OF MDT

NEW

marital status

NFS Score

GROUP

A

Date of MDT

2023-06-14

Co morbidity

Menopausal
status

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

CT RT OVARIAN SMALL BENIGN LOOKING CYST

BX: IDC GII,,LT	ER: 8/8	PR: 8/8	Her 2 Neu : 3	SISH :	KI67 : 18
-----------------------	------------	------------	------------------	--------	--------------

T 3	N 2b	M
--------	---------	---

Sonomammography

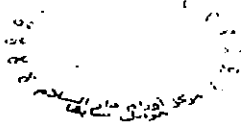
LT UOQ MULTIFOCAL MASSES,,AT 20'CLCOK 4.6X2.8CM,,AT 3 O'CLOCK 2.2X2.4CM
MULTIPLE STALITTE 7X6.4MM,,ONE AXILLARY PLNS,,ONE INFRACLAV 9X5MM

PATIENT HISTORY

MDT OUTCOME & PLAN

start zoladex +NACT (ACx4 then Taxotere x4) guided by clinical response then consider LT MRM.

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	د. شيماء لاشين	RADIOLOGY	د. محمد / 14/6/23
SURGERY	د. مرام محمد التريكات	PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	



Echo report

Name: أم هاشم عبد الله

Date: 27/8/2024

MR: 1782
٢

EF	72%	55-75%	PWT	0.7	0.6-1.1cm
LVEDD	4.8	3.5-5.8cm	AO.R	2.4	2-3.7cm
LVESD		2-4cm	LA	3.3	2-4cm
FS		25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT	0.7	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LVDimensions normal

LV wall thickness normal

LV diastolic function normal

SWMA normal

LA and Aortic root dimensions normal

Mitral Valve normal

Aortic valve normal

Tricuspid valve trivial TR with RSP 21 mmHg

Pulmonary valve normal

Right side and systolic function normal

Intracardiac masses and effusion normal

D/Msc cardiology

د. مياح



اسم المريض ثلاثي: (أ.م.أ. ش.م. عبد الله)
رقم الملف: ١٩٨٢/١٤٢

إقرار الموافقة على علاج كيميائي

أقرنا (أ.م.أ. ش.م. عبد الله) الرقم القومي: ٢٧ ١١ ٥٢١٠١١ ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠
بأنني قد وافقت على تلقي العلاج الكيميائي لعلاج مرض:
عدد الدورات أو المدة المقترحة:
كما أقر بنى تلقيت شرح شامل ما يلي: -

- طبيعة العلاج الكيميائي المقدم وطرق تلقي العلاج.
- الفوائد المرجوة من العلاج الكيميائي ومدى احتمالية نجاحه.
- المخاطر والمضاعفات المحتملة لتلقي العلاج الكيميائي التي قد تشمل الغثيان والقيء، تساقط الشعر، الإمساك، الإحساس بالإرهاق، التهابات الفم والجهاز الهضمي، ضعف المناعة، أنيميا، التهاب المثانة، هشاشة العظام، تأثير وظائف الكلى-الكبد-القلب، العقم عند الذكور، اضطرابات التبويض عند الإناث.
- البدائل المتاحة للعلاج الكيميائي إن وجدت.
- العواقب المحتملة في حالة رفض العلاج الكيميائي.

وهذا إقرار مني بذلك دون أننى مسئولية على الطبيب أو الطاقم الطبي.

أقر بهذا وأوقع عليه

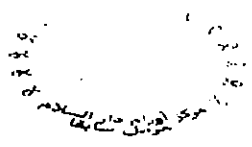
توقيع المريض (أو من ينوب عنه): (أ.م.أ. ش.م. عبد الله) - الصلة القرابة:

اسم الشاهد: التوقيع:

اسم الطبيب: التوقيع:

التاريخ: ٢٠ ١١/١٤/٢٠٢٠ الوقت:

ملحوظة: يتم تغيير الإقرار عند تغيير بروتوكول العلاج



Echo report

Name: ام هاشم عبدالو
Date: 27/8/2024

MR: 1783
C

EF	72%	55-75%	PWT	0.7	0.6-1.1cm
LVEDD	4.8	3.5-5.8cm	AO.R	2.4	2-3.7cm
LVESD		2-4cm	LA	3.3	2-4cm
FS		25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT	0.7	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LVDimensions normal

LV wall thickness normal

LV diastolic function normal

SWMA normal

LA and Aortic root dimensions normal

Mitral Valve normal

Aortic valve normal

Tricuspid valve trivial TR with RSP 21 mmHg

Pulmonary valve normal

Right side and systolic function normal

Intracardiac masses and effusion normal

D/Msc cardiology

د. صالح



Patient Name : أم هاشم عبدالله حفني
Patient No : 1983-2023
Sex : Female Age : 44 Y
Financial Cate : نفقة الدولة - أورام دار السلام
Department : Out Patient
Referring Doc :

Lab No. : 13009106
Request Date : 06-08-2024 08:53
Verification Date : 06-08-2024 10:12
Sample Type : EDTA Blood
Test Status : Routine
Analyzers : XN350_herml

Complete Blood Picture

Test	Result	Unit	Ref. Range
Hemoglobin	<u>11.4</u>	g/dL	12.0 - 16.0
RBCs	<u>3.7</u>	$10^6/\mu\text{L}$	4.0 - 6.5
Haematocrit (PCV)	<u>33.2</u>	%	36.0 - 50.0
MCV	88.8	FL	76.0 - 101.0
MCH	30.5	pg	26.0 - 32.0
MCHC	34.3	g/dL	31.5 - 34.5
RDW-CV	13.7	%	11.6 - 14.0
PLT	216	$10^3/\mu\text{L}$	150 - 450
WBCs.Total	4.3	$10^3/\mu\text{L}$	4.0 - 11.5

Differential Leucocytic Count :

	Relative		Absolute		
Neutrophils%	61.6	%	2.65	/cmm	2.00 - 7.00
Lymphocytes%	25.8	%	<u>1.11</u>	/cmm	1.50 - 3.50
Monocytes %	10.0	%	0.43	/cmm	0.20 - 1.00
Eosinophils %	2.1	%	0.09	/cmm	Up to 0.50
Basophils %	0.5	%	0.02	/cmm	Up to 0.10

Signature

Nouran Emad

Printing Date : 06/08/2024 10:53:56

Page 1 of 1

Printing By : hermal

25311121 / فاكس

25311128

- 25311125 / ت

987 كورنيش النيل الملك الصالح



Patient No. : 1983-2023
Patient Name : الأستاذة / ام هاشم عبدالله حنفى
Sex : Female Age: 44 Y
Financial Cate : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Department : Out Patient
Referring Doc :

Request No : 13009106
Request Date : 06-08-2024 08:53
Verification Date : 06-08-2024 10:47
Sample Type : Serum
Test Status : Routine
Analyzers : biolis_hermel

Clinical Chemistry Report

Test	Result	Unit	Ref. Range
ALT (SGPT)	23.3	U/l	Up to 31.0
AST (SGOT)	18.3	U/l	Up to 31.0
Serum Creatinine	1.0	mg/dl	0.6 - 1.2
Uric acid	<u>6.7</u>	mg/dl	2.6 - 6.0
Urea	39.9	mg/dl	17.0 - 43.0
Calcium Ionized (Ca++)	1.18	mmol/l	1.10 - 1.30
Bilirubin Total	0.72	mg/dl	0.10 - 1.20
Bilirubin Direct	0.08	mg/dL	Up to 0.20

Signature

Nouran Emad

Printing Date : 06/08/2024 10:53:55

Page 1 of 1

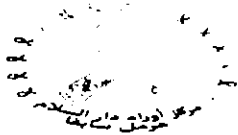
Printing By : hermal

25311121 / فاكس

25311128

- 25311125 / ت

987 كورنيش النيل الملك الصالح



Echo report

Name: ام فاطم عبدالله

Date: 7/5/2024

MR: 19/12/22

EF	71%	55-75%	PWT	0.7	0.6-1.1cm
LVEDD	4.9	3.5-5.8cm	AO.R	2.4	3.7cm
LVESD		2-4cm	LA	3.5	2-4cm
FS		25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT	0.8	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

- LVDimensions normal
- LV wall thickness normal
- LV diastolic function normal
- SWMA no SW, TR
- LA and Aortic root dimensions normal
- Mitral Valve normal
- Aortic valve normal
- Tricuspid valve Tild TR
- Pulmonary valve normal
- Right side and systolic function normal
- Intracardiac masses and effusion no

D/Msc cardiology
ف. ع. ع.

Patient Name: OM HASHEM ABDALLA	Patient ID: 20230828-124550PM
Study Date: 8/28/2023	Age:

Opinion:

- Left UOQ pathologically proven malignant lesions, wit multi centric satellites as above described. the index lesions show progressive course regarding the size.
- Left axillary Level 1, two suspicious lymphnodes.
- Right breast mild fibro adenosis (BIRADS 2).

Dr. Yasmin Essam Khalifa, MD

Women imaging

Date & Time: 8/28/2023 1:36:19 PM

Women's Health Outreach Program

Name : Om Hashim Abdulla Hanafy

Date: 9/5/2023

Bilateral Full field Digital Mammography

Technique:

Mediolateral oblique and CC views

High resolution ultrasound

Clinical summary : Left breast swelling few months ago in 42 years old patient with positive family history

Detailed Findings:

left breast:

- Scattered fibroglandular mammary parenchyma (ACR b).
- UOQ shows multiple spiculated solid mass lesions with suspicious microcalcifications
- Ultrasound UOQ is the seat of multiple ill defined heterogeneous solid mass lesions as follow :-
 - At 2 o'clock measures 4.6x2.8 cm 5 cm from nipple 7 cm from skin .
 - at 3 o'clock measures 2.2x2.4 cm with near by another mass measures 2x1.7 cm
 - multiple satellites measures 7x6.4 mm (3 cm from nipple) , 10x7 mm (2 cm from nipple) .
 - Axillary tail measures 9x5 mm .
- One axillary pathological L.N seen at level I measures 1 cm with lost hilum .
- One infra-clavicular measures 9x5 mm with preserved hilum .
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- ~~Non-specific axillary LNs .~~

Right breast:

- Scattered fibroglandular mammary parenchyma (ACR b).
- No masses asymmetric densities , distortion or suspicious clusters of microcalcifications.
- ~~UOQ is the seat of two well-circumscribed nodules .~~
- Ultrasound demonstrated no solid or cystic lesion .
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs .

Impression :

- left breast (BIRADS 5) : UOQ multifocal malignant solid mass lesions with pathological axillary LNs level I and III for biopsy and histopathological correlation .
- Right breast (BIRADS 1) : Normal study

Best regards,

Dr/Nashwa A. El Kader

well-circumscribed nodules
solid or cystic lesion

pathological
histopathological correlation

Bilateral Mammography and High resolution Breast Ultrasound Revealed

Complaint: Follow up on pathologically proven left UOQ IDC on neo adjuvant treatment.

Findings:

- Heterogeneous dense breast (Acr c).
- Left UOQ irregular speculated dense lesion with segmental area pleomorphic micro calcifications measuring about 6.5x3.8 cm.
- No dominant masses or suspicious microcalcifications in the right breast.
- Complementary ultrasound revealed
- Left 2:00 midzonal irregular speculated hypoechoic lesion measuring 5.6x3x4.5 cm, with near by satellite measuring 0.6x0.5 cm.
- Left 3:00 irregular speculated hypoechoic lesion with internal micro calcifications, measuring 2.2x1.2x2.6 cm.
- multi centric satellites are seen as rounded hypoechoic lesions with angulated and indistinct margins seen at:
 - 11:00 para areolar: 0.5x0.4x0.4 cm
 - 10:00 para areolar: 0.9x0.7x0.9 cm
 - 5:00 mid zonal deep: 0.5x0.4x0.4 cm
 - retro areolar: 0.45x0.4x0.4 cm.
- No right solid or cystic lesions.
- Normal skin thickness and contour.
- Normal nipple areola complex.
- Right non specific axillary lymph nodes.
- Left small globular sub centimetric lymphnode with lost hilum is noted and another one with preserved hilum yet showing diffuse cortical thickening reaching 2.4 mm in thickness.
- No pathologically enlarged infra or supra clavicular lymphnodes.

1913
ع. ع. ع.
ام هاشم عبد الله

Patient Name: CM HASHEM ABDALLA	Patient ID: 20230828-124550PM
Study Date: 8/28/2023	Age:

Opinion:

- Left UOQ pathologically proven malignant lesions, wit multi-centric satellites as above described. the index lesions show progressive course regarding the size.
- Left axillary Level 1, two suspicious lymphnodes.
- Right breast mild fibro adenosis (BIRADS 2).

Dr. Yasmin Essam Khalifa, MD

Women Imaging

Date & Time: 8/28/2023 1:36:19 PM

[illegible]



إسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:

Doctor's Orders أوامر الطبيب

التشخيص: نوع التغذية:

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		26/7/2025 : P.A. V/S live postprandial Duplex R.A. Venous Echocardiography Left Kidney R. Zaladex 100 mg R. Naloxone 20 mg (x1) R. One Alfa 100 mg R. Calcein 100 mg Dr. [Signature]	سجل شهر Zaladex 17/8 Brutt

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

وزارة الصحة و السكان
أمثلة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أودام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

Doctor's Orders **اوامر الطبيب**

~~ER 8/8~~

PR 8/8

$$\frac{he^{12}}{+3}$$

نوع التغذية

التشخيص:

Adj: phesgo

Polystyrol
Nolvadex

C17

توقيع الطبيب

الأوامر

لوقت

التاريخ

.....	عنسيحجو.....7.....	عنت الحلسد
.....	تامو فشتب ٩	
.....	كالمسيوم	يوعميا المسدة
.....	وان الفنا	شلا شله شهر

— ۱۰۰ —
ع. ق. ا. ق. ا. ق.

C16 pheryo
صا عسریل
C.co/c/co

[illegible]

منیر. علی

S.m. (R)

C.C. 10/4

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

وزارة الصحة و السكان
أمّاتة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

.....: نوع التغذية:: الشخص:

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		EF = 70% 19.11.2024 فريق طبي ... قاصد ... ك ... ل ... ص ... د ... 11/11/2024 CL6 لا	توقيع الطبيب

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

۵۰. کانداز شوی
C/phe ۵۰

اسم المريض ثلاثي: محمد بن عبد الله
رقم الملف: ١٩٨٤١

Doctor's Orders **اوامر الطبيب**

التشخيص:..... **نوع التغذية:.....**

[illegible]

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

اسم المريض ثلاثي:
رقم الملف: ١٦٨٣/٤٣



وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أودام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

ام هاج عبد الله

Doctor's Orders - أوامر الطبيب

التشخيص: نوع التغذية:

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
27/8/2024		ECHO EF 722 (27/8/2024) C11 phes 27/8/2024 دا هاج عبد الله	
17/9/2024		C12 phes 17/9/2024 دا هاج عبد الله	

جميع الأوامر الطبية لا بد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

Doctor's Orders **اوامر الطبيب**

[illegible]

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

.....: نوع التغذية: التشخيص:

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
25/6/2024	10:00	فسيكو تامو كالمسيو ديفيتون بالسيم فسيكو تامو كالمسيو ديفيتون بالسيم	فسيكو تامو كالمسيو ديفيتون بالسيم

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

وزارة الصحة و السكان
امانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام " هرمل "
ادارة الجودة



اسم المريض ثلاثي: ام مكيه عبد الله
رقم الملف: ٤٩٨٢ / ٥

Doctor's Orders **اوامر الطبيب**

التشخيص: نوع التغذية: EF 5/2024: 71 %

[illegible]

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة ومفهومة من الطبيب /

بار و کرم
و اسم است (مع)

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

.....: نوع التقنية:

法蘭西

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

10.8

CS phesgo
23/5/2020
2020/5/23

Page 6 of 1

رقم الملف:

ILC 2.5
-9
for GOLF
(1) MS!

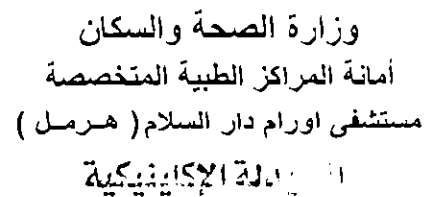
Page 1 of 1



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام (هرمل)
المسئولة الإكلينيكية

carb
Docetaxel + Trastuzumab + Pertuzumab Q 3 weeks Cycle (...)

التاريخ: 2022/11/11		اليوم:	
رقم الملف:		اسم المريض: <i>أ.م. هاشم عبد الله خضر</i>	
Weight: kg	Height: cm	BSA: M2	Age: years
CBC:	WBC: ANC: Hgb: PLT:		
Functions Tests:	Sr.Creat: Urea: ALT: AST: T.Bil: D.Bil:		
Echo:	Date: EF: %		
Dose Modification: %			
Reason: ☐ Hematological ☐ Non hematological:			
امضاء التمريض	بروتوكول العلاج		الصرف
	جرانيسترون (0.01 مجم/كجم) مجم + ديكساميثازون 20 مجم + انتودين 20 مجم + امبول افيل) في 50 مل ج 5% علي مدي ربع ساعة قبل العلاج الكيماوي. (Maximum dose of Granisetron =1mg)		
	هرتوزوماب مجم في 250 مل ملح علي مدي 1/2 ساعة (علي مدي ساعة في الجرعة الاولى) Loading Dose: 840 mg Maintenance Dose: 420 mg		
	تراستوزوماب 600 مجم تحت الجلد لمدة 5 دقائق في الفخذ		
	دوسيتاكسل (75 مجم/م) مجم في 500 مل ج 5% علي مدي ساعتين.		
	50 مل ج/ملح علي مدي 10 دقائق <i>AUC 5</i>		
العلاج التذعيمي: ديكساميثازون 8 مجم (امبول او قرص) كل 12 ساعة لمدة 3 ايام تبدأ اليوم السابق للجرعة. <i>C6 TC (610mg)</i> <i>C6 TC</i> <i>تم صرف تاكسونيد كابريل</i>			
Physician Signature:	Clinical pharmacy: <i>علاج امبرج</i> <i>لهو عبد الكريم</i> <i>2022/11/11</i>	Dispensing pharmacy:	



اليوم:		التاريخ: ٢٠٢٢/٠٧/٠٤	
اسم المريض: أ.م. هاشم عيسى		رقم الملف: ١٩٨٢/٤٢	
Weight: 84 kg	Height: 165 cm	BSA: 1.96 M2	Age: years
CBC:	WBC: ANC: Hgb: PLT:		
Functions Tests:	Sr.Creat: Urea: ALT: AST: T.Bil: D.Bil:		
Echo:	Date: 15/6 EF: 65 %		
Dose Modification: %			
Reason: ☐ Hematological ☐ Non hematological:			
الصرف	بروتوكول العلاج		
	امضاء التمريض		
	جرانيسترون (0.01 مجم/كجم) مجم + ديكساميثازون 12 مجم + انتودين 20 مجم + امبول افيل) في 50 مل ج 5% علي مدي ربع ساعة قبل العلاج الكيماوي. (Maximum dose of Granisetron =1mg)		
	دوكسوروبيسين (60 مجم/م) ١.١.٠.٥ مجم في 100 مل ج 5% علي مدي 1/2 ساعة		
	50 مل ج/ملح علي مدي 10 دقائق		
	سيكلوفوسفاميد (600 مجم/م) ١.١.٠.٥ مجم في 250 مل ملح علي مدي 1/2 ساعة		
	50 مل ج/ملح علي مدي 10 دقائق		
العلاج التدعيمى:	كونترولوك قرص 40 مجم علي الريق لمدة اسبوع. ديكساميثازون 8 مجم قرص يوميا من اليوم الثاني للرابع. ايمند قرص 125 مجم اليوم الاول و 80 مجم اليوم الثاني و الثالث. برسيف ٦ - ٢٠٠٠ مجم		
Dispensing pharmacy:	Clinical pharmacy:	Physician Signature:	



اسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:

Doctor's Orders الاوامر الطبيب

التشخيص: نوع التغذية:

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		$Lt. CT_3 N_3 M_{0CT}$ $INDC Cr II$ $\hookrightarrow NACT = 4AC \rightarrow 4T_{act}$ $ER 818 PR 818 H_2 = 3$ $K_{act} = 18$ $\hookrightarrow C, AC$ $CC 17/55$	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

.....: اسم المريض ثلاثي:
.....: رقم الملف:

Doctor's Orders **اوامر الطبيب**

التشخيص: **نوع التغذية:**

[illegible]

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

رقم الملف: ١٩٨٢/٤٢٢

kur 2

اسم المريض ثلاثي: اسمها اسم بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الملف: ٢٣١٩٨٣٠٠٠



وزارة الصحة و السكان
امانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أودام دار السلام " هرمل"
إدارة الجودة

Doctor's Orders الأوامر الطبيب

التشخيص: نوع النخية:
ABW 67.7

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		Patient printed today CK - Proge for Cycle (2) Toxotene 140.5 Cambophene AUCS Phasago 1200/600 Gile I Methabigen 1.2 Controler 400 Erond 1.2 Ondulez 5.0 Namozem 1.2 Amino Phyllin 1.2 27/10/2023 Cent x T x Carb (512) 140 → Phesgo after Echo on 7/10/2023 (approved) Car Ph /	

بسم الله الرحمن الرحيم

مرشمة بونا 1.2

مرشمة بونا 1.2

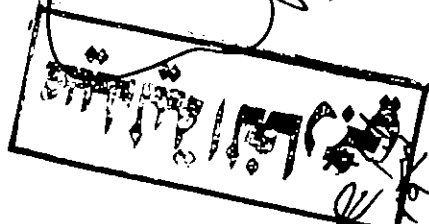
مرشمة بونا 1.2

مرشمة بونا 1.2

مرشمة بونا 1.2

مرشمة بونا 1.2

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب



وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أودام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة



اسم المريض ثلاثي: ٥٤١ الحبيبة الد
رقم الملف: ٢٣١٩٨٢ C

Doctor's Orders **اوامر الطبيب**

.....: **التشخيص:**: **نوع التغذية:**

[illegible]

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "
إدارة الجودة

.....:التشخيص::نوع التقنية:.....

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		26 / 10 / 2023 labos pending C₂ phergo 600 / 600 5. C فريق بي 7-7 حصة كماله بي راجل / م 2 مراح - جراسيتريل امينيد في جرسيك يوميا - لوتيفوريلوكت 800 في جرسيك يوميا C₂ phergo ص 4 C₁ 157	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام (هرمل)
العيادة الإكلينيكية

25/10/2021
don
reduct

Docetaxel + Trastuzumab Protocol Cycle (.....)

اليوم:		التاريخ: 2021 / /	
أسم المريض: ...		رقم الملف: ...	
Weight: 84 kg	Height: 165 cm	BSA: 1.96 M2	Age: 43 years
CBC:	WBC:	ANC:	Hgb:
PLT:	Sr.Creat: 7.6	Urea:	ALT:
AST:	T.Bil:	D.Bil:	EF:
Dose Modification: %			
Reason: ☐ Hematological ☐ Non hematological:			
الصرف	بروتوكول العلاج		
	جرانيسترون (0.01 مجم/كجم) مجم + ديكساميثازون 12 مجم + انتودين 20 مجم + امبول افيل) في 50 مل ج 5% علي مدي ربع ساعة قبل العلاج الكيماوي. (Maximum dose of Granisetron = 1mg)		
	دوسيتاكسل (75 مجم/م2) مجم في 500 مل ج 5% علي مدي 10 دقائق		
	50 مل ج 5% علي مدي 10 دقائق		
N.B: Trastuzumab SQ is given for Adjuvant setting Trastuzumab IV is given for MBC			
	☒ تراستوزوماب 600 مجم تحت الجلد لمدة 5 دقائق في الفخذ. ☐ تراستوزوماب مجم علي 250 مل ملح لمدة نصف ساعة. (علي 500 مل ملح لمدة ساعة ونصف الجرعة الاولى فقط) Loading Dose: 8 mg/m2 Maintenance Dose: 6 mg/m2 (MAX: 440 mg)		
العلاج التديمي:			
كونترولوك قرص 40 مجم علي الريق لمدة اسبوع. ديكساميثازون 8 مجم (امبول او قرص) كل 12 ساعة لمدة 3 ايام تبدأ اليوم السابق للجرعة ٥ x ١ x ١ ١٤ x ٢ x ١			
Physician Signature:	Clinical pharmacy:	Dispensing pharmacy:	

..... اسم المريض ثلاثي:
 رقم الملف:



وزارة الصحة و السكان
 أمارة المراكز الطبية المتخصصة
 مستشفى أودام دار السلام " هرمل "
 إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

Age 43

wt 86

..... نوع التغذية:

116165

BSA 96

AR 67

توقيع الطبيب	الأوامر	الوقت	التاريخ
411116	for Neph + teleh	BSA	96
		AR 67	
		C3	
CBC - ok	فحص دم - 7-6		
	لiver		
	5 Crea		
	Cr 11/4		
	2.5% dose reduction		
Sr cr 7.6	Urea		
Cr 10.2	neuropathy		
to monitor			
	4.11.2022		
	Sr 7-6		
	UA 168		
	PH: 7.21		
	for Neph		
	ICU		

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب

for Neph

ICU

11/4

EP Gu. 1.

7/10/23

التشخيص: نوع التغذية:

3 phesot 4 Te
dph
Volen
19 11
23

مستند ۱۹/۴

Doctor's Orders **اوامر الطبيب**

التنظيف: $NACH$ نوع التغذية:

تاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		(25 % ع)	مسلمه 28 Feb
		1. 1000 mg 2. 1000 mg 3. 1000 mg 4. 1000 mg 5. 1000 mg 6. 1000 mg 7. 1000 mg 8. 1000 mg 9. 1000 mg 10. 1000 mg 11. 1000 mg 12. 1000 mg 13. 1000 mg 14. 1000 mg 15. 1000 mg 16. 1000 mg 17. 1000 mg 18. 1000 mg 19. 1000 mg 20. 1000 mg 21. 1000 mg 22. 1000 mg 23. 1000 mg 24. 1000 mg 25. 1000 mg 26. 1000 mg 27. 1000 mg 28. 1000 mg 29. 1000 mg 30. 1000 mg 31. 1000 mg 32. 1000 mg 33. 1000 mg 34. 1000 mg 35. 1000 mg 36. 1000 mg 37. 1000 mg 38. 1000 mg 39. 1000 mg 40. 1000 mg 41. 1000 mg 42. 1000 mg 43. 1000 mg 44. 1000 mg 45. 1000 mg 46. 1000 mg 47. 1000 mg 48. 1000 mg 49. 1000 mg 50. 1000 mg 51. 1000 mg 52. 1000 mg 53. 1000 mg 54. 1000 mg 55. 1000 mg 56. 1000 mg 57. 1000 mg 58. 1000 mg 59. 1000 mg 60. 1000 mg 61. 1000 mg 62. 1000 mg 63. 1000 mg 64. 1000 mg 65. 1000 mg 66. 1000 mg 67. 1000 mg 68. 1000 mg 69. 1000 mg 70. 1000 mg 71. 1000 mg 72. 1000 mg 73. 1000 mg 74. 1000 mg 75. 1000 mg 76. 1000 mg 77. 1000 mg 78. 1000 mg 79. 1000 mg 80. 1000 mg 81. 1000 mg 82. 1000 mg 83. 1000 mg 84. 1000 mg 85. 1000 mg 86. 1000 mg 87. 1000 mg 88. 1000 mg 89. 1000 mg 90. 1000 mg 91. 1000 mg 92. 1000 mg 93. 1000 mg 94. 1000 mg 95. 1000 mg 96. 1000 mg 97. 1000 mg 98. 1000 mg 99. 1000 mg 100. 1000 mg	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب



..... رقم الملف:

.....: نوع التغذية:: الشخص:

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		labs. → pending ليس يوجد قرار استئصال لا phesgo ثم تشايحه في اليوم for C6 T-C	12/2023

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب